Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Sarandi

Rua Senador Alberto Pasqualini, 1211 - Bairro: Centro - CEP: 99560000 - Fone: (54)99907-8215 - (54)3046.9896 - Email: frsarandivjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002709-45.2023.8.21.0069/RS

AUTOR: JOANA IVONE KREIN GAZZONI

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Trata-se de ação para fornecimento de medicamento que **JOANA IVONE KREIN GAZZONI** move em face de **CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL**.

Narrou apresentar quadro de anemia hemolítica autoimune (CID 10 D59.1) desde janeiro de 2022, tendo utilizado medicamentos sem resposta. Em julho de 2023 a médica hematologista prescreveu o uso do medicamento Riximyo 500mg/ml e Riximyo 100mg/ml, uma vez por semana por quatro semanas. Destacou que a medicação deve ser aplicada exclusivamente em ambiente hospitalar. Disse que houve negativa "*com a justificativa de que está fora das recomendações do plano de saúde*". Requereu liminarmente o fornecimento do medicamento. Postulou a procedência do pedido e a concessão da gratuidade de justiça (evento 1, INIC1).

Deferido o pedido de antecipação de tutela (evento 3, DESPADEC1) .

Informado pelo autora o descumprimento da liminar (evento 9, PET1).

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a autora para recolher custas, bem como determinado o sequestro de valores para aquisição do medicamento e deferido o pedido de determinar à ré que arque com as despesas de internação hospitalar da autora para a aplicação do medicamento, através do plano de saúde, sob pena de bloqueio (evento 11, DESPADEC1).

Custas pagas pela autora (evento 17).

A parte ré compareceu aos autos informando o cumprimento da liminar (evento 20, PET1) e requerendo a restituição do valor bloqueado (evento 21, PET1).

O réu contestou a ação, alegando, preliminarmente: a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) a necessidade de revogação da tutela de urgência; c) a impugnação ao valor da causa; d) a imprescindibilidade de comprovação documental do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 147.454/2022; e) pedido genérico; f) e a impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, alegou que não há recomendação do CONITEC quanto ao uso de rituximabe no tratamento da doença da autora, havendo exclusão da cobertura contratual, uma vez que embora o tratamento pleiteado esteja presente no rol da ANS, não preencge os requisitos da DUT 65. Discorreu sobre reembolso. Requereu a improcedência do pedido (evento 22, PET1).

Determinada a devolução de valores à ré (evento 24, DESPADEC1).

Houve réplica (evento 45, RÉPLICA1).

Intimadas as partes para produção de provas (evento 48, ATOORD1).

A parte ré requereu a expedição de ofício ao NATJUS (evento 53, PET1), o que foi indeferido (evento 36, DESPADEC1 e evento 56, DESPADEC1)

Vieram os autos conclusos para sentença.

RELATEI.

DECIDO.

Da impugnação ao valor da causa

Tratando-se de recomendação de 4 ciclos de medicação, correto o valor atribuído à causa para aquisição da medicação, conforme orçamento (evento 1, OUT9).

Destaca-se que em caso de tratamento contínuo, o valor atribuído à causa deveria corresponder ao valor do tratamento por 12 meses. No entanto, não havendo menção na inicial ao uso contínuo da medicação, mantenho o valor atribuído pela autora.

Da impugnação à gratuidade de justiça

O pedido de gratuidade de justiça foi inderido (evento 11, DESPADEC1), tendo a autora recolhido as custas do processo (evento 17).

As demais alegações preliminares se confundem com o mérito da demanda e com eles serão analisadas.

Passo a analisar o mérito.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que almeja a autora seja determinado à ré o cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento e aplicação do medicamento Riximyo 500mg/ml e Riximyo 100mg/ml uma vez por semana por quatro semanas para o enfrentamento da moléstia que o acomete – CID 10 D59.1.

No caso em análise, restou incontroversa a contratação do plano de saúde (evento 1, COMP5 e evento 1, PROCADM7), bem como o diagnóstico e recomendação médica para o uso do medicamento postulado (evento 1, LAUDO6).

A matéria controvertida, contudo, cinge-se na obrigatoriedade (ou não) de cobertura do procedimento médico pelo plano de saúde à luz do quadro clínico específico da autora.

Ressalta-se que, por ser a requerida uma entidade de autogestão, fica afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor a hipótese dos autos, nos termos da Súmula 608 do STJ: *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Não obstante, devem ser observados, em todos os tipos de contratação, o disposto nos artigos 422, 423 e 424 do Código Civil, que apresentam, em sua redação, os princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos:

> *Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.*
>
> *Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.*
>
> *Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.*

Ressalto, por oportuno, que o STJ já se manifestou sobre a possibilidade de avaliação das cláusulas constantes nos contratos firmados com entidades de autogestão, nos seguintes termos:

> *AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE OPERA POR AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR - OFF LABEL - EXPERIMENTAL - ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE.*
>
> ***1. A avaliação acerca da abusividade da conduta de entidade de autogestão ao negar a cobertura de medicamentos ou tratamentos médicos está sujeita à aplicação subsidiária das normas gerais e dos preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado, a teor dos artigos 422, 423 e 424 do CC.***
>
> *Precedentes.*
>
> *2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão.*
>
> *3. Agravo interno não provido.*
>
> *(AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018) - grifou-se.*

Dito isto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha alterado, em 08/06/2022, o entendimento no sentido de reconhecer a taxatividade do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), em 22/09/2022 foi publicada a Lei n.º 14.454/2022, que estabelece critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS:

> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico, ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.*

Da mesma forma, é assente o entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, pois tal incumbência é do profissional que assiste o paciente, a quem compete avaliar os riscos e benefícios do tratamento e indicar a alternativa mais adequada (STJ, Resp nº 668.216-SP, j. 15.03.2007).

Seguindo essa linha de raciocínio, é decorrência lógica considerar que o rol de procedimentos previsto nas normas da ANS não é taxativo, traduzindo somente um referencial de coberturas básicas para os planos de saúde.

Em casos similares, assim já decidiu o TJRS, inclusive, acerca do medicamento postulado:

> *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.* ***PLANO DE SAÚDE. ENXAQUECA EPISÓDICA. MEDICAMENTO ERENUMABE (PASURTA). NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. REEMBOLSO DE VALORES DEVIDO.*** *DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. NO CASO EM TELA, A AUTORA APRESENTA ENXAQUECA EPISÓDICA (MIGRÂNEA) FREQUENTE (CID-10: G43.9) HÁ 30 ANOS, COM PADRÃO DE DOR E CERCA DE DEZ CRISES POR MÊS DE FORTE INTENSIDADE, COM POUCA OU NENHUMA RESPOSTA A ANALGÉSICOS (NAPROXENO E SUMATRIPTANO), ASSOCIADO A NÁUSEAS E COM DURAÇÃO SUPERIOR A 24 HORAS, SENDO*

INDICADO O USO DO MEDICAMENTO ERENUMABE (PASURTA), NA DOSE DE 70MG, POR VIA SUBCUTÂNEA, UMA AMPOLA, UMA VEZ AO MÊS. A COBERTURA RESTOU NEGADA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ATENDIDA A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO PREVISTA NO ROL DA ANS. II. ENTRETANTO, OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADOS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA NESTA RELAÇÃO. DE OUTRO LADO, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, ***NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, AINDA QUE NÃO HAJA PREVISÃO NO ROL DA ANS, MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, OU NÃO ATENDIDA EVENTUAL DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. ALÉM DO MAIS, DEVE SER PRIORIZADO O DIREITO À SAÚDE E À VIDA EM RELAÇÃO AO DIREITO CONTRATUAL.*** *INCIDÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, § 1°, II, DO CDC. III. ASSIM, A LUZ DO ESTATUTO CONSUMERISTA E DA LEI N° 9.656/98, MOSTRA-SE ABUSIVA A NEGATIVA DA COBERTURA DO TRATAMENTO PRESCRITO À DEMANDANTE. IV. LOGO, É DEVIDA A COBERTURA DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO. POR CONSEQUÊNCIA, DEVERÃO SER RESSARCIDOS OS VALORES JÁ DESPENDIDOS PELA PARTE AUTORA. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.(APELAÇÃO CÍVEL, Nº 50512944620208210001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, JULGADO EM: 28-04-2021) - grifou-se.*

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENXAQUECA CRÔNICA E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. MEDICAMENTO ERENUMABE (PASURTA). NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. NO CASO EM TELA, A AUTORA APRESENTA ENXAQUECA CRÔNICA (MIGRÂNEA - CID10 G43.9) E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE (CID10 G40), SENDO INDICADO O USO DO MEDICAMENTO ERENUMABE (PASURTA), NA DOSE DE 70MG, POR VIA SUBCUTÂNEA, UMA AMPOLA, UMA VEZ AO MÊS. A COBERTURA RESTOU NEGADA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ATENDIDA A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO PREVISTA NO ROL DA ANS. II. ENTRETANTO, ***OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADOS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA NESTA RELAÇÃO. DE OUTRO LADO, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, AINDA QUE NÃO HAJA PREVISÃO NO ROL DA ANS, MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, OU NÃO ATENDIDA EVENTUAL DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO.*** *ALÉM DO MAIS, DEVE SER PRIORIZADO O DIREITO À SAÚDE E À VIDA EM RELAÇÃO AO DIREITO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, § 1°, II, DO CDC. III. ALIÁS, CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O LOCAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO É IRRELEVANTE PARA DEFINIR O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. EM OUTRAS PALAVRAS, SE HÁ COBERTURA PARA A DOENÇA, DEVE SER FORNECIDO O MEDICAMENTO MINISTRADO PELO MÉDICO, MESMO QUE PARA USO DOMICILIAR. IV. ASSIM, A LUZ DO ESTATUTO CONSUMERISTA E DA LEI N° 9.656/98,* ***MOSTRA-SE ABUSIVA A NEGATIVA DA COBERTURA DO TRATAMENTO PRESCRITO À DEMANDANTE. LOGO, É DEVIDA A COBERTURA DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO. V. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC****, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50196349720218210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-07-2022) - grifou-se.*

No caso em apreço, restou comprovado que o tratamento postulado se mostra imprescindível para o tratamento da doença que acomete a autora, conforme laudo médico acostado à inicial (evento 1, LAUDO6):

Laudo Médico

Paciente Joana Ivone K. Gazzoni, 77anos, apresenta quadro de anemia hemolítica autoimune desde janeiro de 2022 (CID 10: D 59.1). Paciente realizou múltiplos cursos de corticoterapia nesse período, mas atualmente em uso de corticoide desde dezembro de 2022 e sem resposta, já com paraefeitos da medicação. Iniciou tratamento imunossupressor com ciclofosfamilda, mas segue com anemia sintomática. Paciente sem performance para esplenectomia. Dessa forma, como paciente segue com anemia sintomática e conforme revisão de literatura tem a indicação de tratamento com rituximabe (Riximyio, Vivvaxia, Trixiuma) na dose de 375 mg/m2 > dose por semana por 4 semanas, conforme receita em anexo, com plano de realizar quatro ciclos de tratamento, nesse primeiro momento. O não uso da medicação acarreta aumento de risco de recidiva precoce de doença e aumento de morbimortalidade. A medicação não é fornecida pelo SUS, não sendo coberta por APAC. Declaro que não possuo nenhum conflito de interesse com a indústria farmacêutica na prescrição desta medicação que não o bem estar do paciente.

Passo Fundo, 28 de julho de 2023

Verifica-se que tal laudo é suficiente para comprovar a necessidade do uso do fármaco e o melhor tratamento a ser administrado, bem como diante da ausência de qualquer prova contundente em sentido contrário produzida pelo réu.

A operadora do plano de saúde não está autorizada a fazer a escolha do método mais adequado para o tratamento da doença da autora ou simplesmente negá-lo, pois isso compete ao profissional que tem conhecimento da medicina.

Há que se atentar, ainda, para que o contrato firmado pelas partes não exclui a cobertura de tratamento para a moléstia apresentada pela autora, pelo que não pode a entidade, agora, negar-se a arcar com as despesas do medicamento indicado pelo médico do paciente.

Desta forma, afigura-se indevida a recusa da requerida, sendo seu dever fornecer o tratamento pleiteado.

POR TAIS RAZÕES, forte no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial por **JOANA IVONE KREIN GAZZONI** em face do **CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL,** para o fim de confirmar a tutela deferida e condenar a ré a fornecer o medicamento Riximyo 500mg/ml na quantidade de 500mg uma vez por semana e Riximyo 100mg/ml na quantidade de 150mg uma vez por semana, bem como para que arque com as despesas de internação hospitalar da autora para a aplicação do medicamento, em ciclo de quatro semanas, pelo período que o tratamento se fizer necessário.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários ao procurador da parte autora, os quais vão fixados em R$ 2.000,00, usando-se por analogia o art. 85, § 8º, do CPC, já que o valor é alto e se trata de obrigação de fazer constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento objetivando a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens estes cujo valor é inestimável (STJ - AgInt no AREsp 1568584/SP).

Publicada e registrada a sentença, bem como intimadas as partes, eletronicamente, via sistema Eproc.

Sobrevindo embargos de declaração, desde já, determino a intimação da parte adversa para contrarrazões, no prazo legal.

Em sendo interposto recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, desde já fica determinada a intimação do apelante para apresentar contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.010, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após, revisados e anotados, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Após, em nada mais sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ANDREIA DOS SANTOS ROSSATTO, Juíza de Direito**, em 10/06/2025, às 14:58:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084279046v12** e o código CRC **3ac99118**.